ICS 11.020
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.16—2013

针灸技术操作规范
第 16 部分:腹针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 16:Abdominal acupuncture

2013-12-31 发布 2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为以下22部分：

——第1部分：艾灸；

——第2部分：头针；

——第3部分：耳针；

——第4部分：三棱针；

——第5部分：拔罐；

——第6部分：穴位注射；

——第7部分：皮肤针；

——第8部分：皮内针；

——第9部分：穴位贴敷；

——第10部分：穴位埋线；

——第11部分：电针；

——第12部分：火针；

——第13部分：芒针；

——第14部分：鍉针；

——第15部分：眼针；

——第16部分：腹针；

——第17部分：鼻针；

——第18部分：口唇针；

——第19部分：腕踝针；

——第20部分：毫针基本刺法；

——第21部分：毫针基本手法；

——第22部分：刮痧。

本部分为GB/T 21709的第16部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本部分由广东省中医院负责起草，北京中医药大学、北京中医药大学附属护国寺中医院、北京薄氏腹针研究院参加起草。

本部分起草人：薄智云、符文彬、林超岱、张红林、王丽平、陈秀华、朱晓平、薄聪雁。

引　　言

一般标准中所涉及的长度、宽度的计量都要求采用国际单位制，但是人体高矮胖瘦的差异很大，无法采用绝对的标准值描述针灸腧穴部位，只有通过等分折量的方法——骨度折量法描述腧穴部位，才能适用于所有人群和所有个体。1987 年世界卫生组织在韩国汉城召开的国际会议上，确定采用“寸”作为针灸经穴标准计量单位。因此，本标准的腧穴定位采用这种计量单位。

针灸技术操作规范
第16部分:腹针

1 范围

GB/T 21709的本部分规定了腹针及相关术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本部分适用于腹针技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2024 针灸针

GB/T 12346 腧穴名称与定位

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

腹针 abdominal acupuncture

在腹部针刺特定穴点治疗全身疾病的方法。

3.2

天部、人部、地部 tian-ren-di needling depths

腹针将在腹壁的进针深度分为天、人、地三个层次,天部是指刺至腹部真皮层和皮下;人部是指刺至腹部浅筋膜和脂肪层,位于天部与地部之间;地部是指刺至腹部肌层。

3.3

腹纵线 abdominal vaertical line

人体仰卧时,从中庭穴至曲骨穴的水平纵线。

3.4

腹横线 abdominal horizontal line

人体仰卧时,由神阙穴通过两个天枢穴延伸的水平横线。

3.5

定位穴点 fixed point (s)

腹针中具有标志作用的穴点,由部分传统经穴与腹针特定穴点组成,有规律地分布于以神阙穴为中心的上下左右,定位穴点同时也具有治疗作用。

注:定位穴点的名称、代码、部位与取穴示意图参见附录A。

3.6

对应穴点 corresponding point (s)

在两个相邻的定位穴点之间取穴,依据病变部位及病症不同,选取相应的对应穴点。也是腹部针的主要治疗点。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 针具选择

采用符合 GB 2024 的毫针。

4.1.2 体位选择

患者取仰卧位,暴露腹部。

4.1.3 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

4.1.4 消毒

4.1.4.1 针具消毒

选用重复使用的毫针时应选择高压蒸汽灭菌法或选择符合 GB 2024 的一次性无菌毫针。

4.1.4.2 部位消毒

用 75%医用乙醇或碘伏在施术部位消毒。

4.1.4.3 医者消毒

医者双手应用肥皂水清洗干净,再用 75% 医用乙醇擦拭。

4.2 取穴方法

4.2.1 比例寸的确定

依据骨度分寸原则折量比例寸。其中:

a) 上腹部:腹纵线由神阙穴至中庭穴为 8 寸;

b) 下腹部:腹纵线由神阙穴至曲骨穴为 5 寸;

c) 侧腹部:腹横线由神阙穴通过一侧天枢穴至侧腹腋中线为 6 寸。

4.2.2 方法

采用标准量尺在腹纵线与腹横线上按比例寸进行测量,先选取腹针定位穴点,然后根据病情和处方选取腹针对应穴点。

4.3 施术方法

4.3.1 进针

根据处方要求按照“先上后下,先内后外”的原则顺序进针,针尖垂直于床面刺入皮下。疼痛性疾病可采用腹针常用刺法。腹针常用刺法参见附录 B。

4.3.2 行针

在天部停留 3 min 后,根据处方要求将针刺深度调整至相应的天部或人部或地部,不要求患者“得

气”,可依据病情对针刺的方向、角度进行微调,然后留针。腹针处方原则参见附录 C。

4.3.3 留针

留针 25 min～30 min。

4.3.4 出针

根据进针顺序,缓慢将针捻转提出,用干棉球按压针孔。腹针适应病症参见附录 D。

5 注意事项

5.1 操作部位应注意防止感染。
5.2 过度饥饿、过度激动、大怒者慎用。

6 禁忌

6.1 有自发性出血或损伤后出血不止者禁针。
6.2 原因不明的急腹症者禁针。
6.3 怀孕四个月以上的孕妇禁针。
6.4 腹部皮肤有感染、溃疡、肿物、瘢痕处禁针。

附　录　A
（资料性附录）
腹针定位穴点的名称、代码、部位与腹针取穴示意图

A.1　腹针定位穴点的名称、代码与部位（见表 A.1）

表 A.1　腹针定位穴点的名称、代码与部位表

名称与代码	部位
中脘 CV12	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
阴都 KI19	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
下脘 CV10	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
商曲 KI17	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
水分 CV9	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
滑肉门 ST24	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
天枢 ST25	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
外陵 ST26	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
气海 CV6	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
关元 CV4	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
气穴 KI13	同 GB/T 12346　腧穴名称与定位
上风湿点 AB1	滑肉门穴向外 5 分向上 5 分
上风湿外点 AB2	滑肉门穴向外 1 寸
上风湿上点 AB3	下脘穴（CV10）外 3 寸
下风湿点 AB4	外陵穴向下 5 分向外 5 分
下风湿内点 AB5	外陵穴（ST26）下 5 分
下风湿下点 AB6	下风湿点向下 5 分向外 5 分
气旁 AB7	气海旁开 5 分处

注 1：AB 是腹针规定的部分定位穴点或对应穴点的代码。

注 2：AB3 为上风湿上点，位于下脘穴（CV10）外 3 寸；AB5 为下风湿内点，位于外陵穴（ST26）下 5 分。AB3、AB5 是腹针对应穴点。

A.2　腹针取穴示意图

腹针取穴主要依据定位穴点，各个定位穴点实际上代表了人体各部位在腹部的对应部位：颈部位于两个商曲穴；头部位于中脘穴上下；腰骶部从两个气旁穴向下延伸，终于关元穴附近；上肢由滑肉门穴引出，在上风湿点穴屈曲，止于上风湿外点穴；下肢由外陵穴向外伸展，止于下风湿下点穴。这些定位穴点的连线形成一个酷似龟形的图形，故又称“神龟图”，见图 A.1。

当人体有病症时，可以根据病变部位在“神龟图”的位置（图 A.1）中选取相关对应穴点进行治疗。

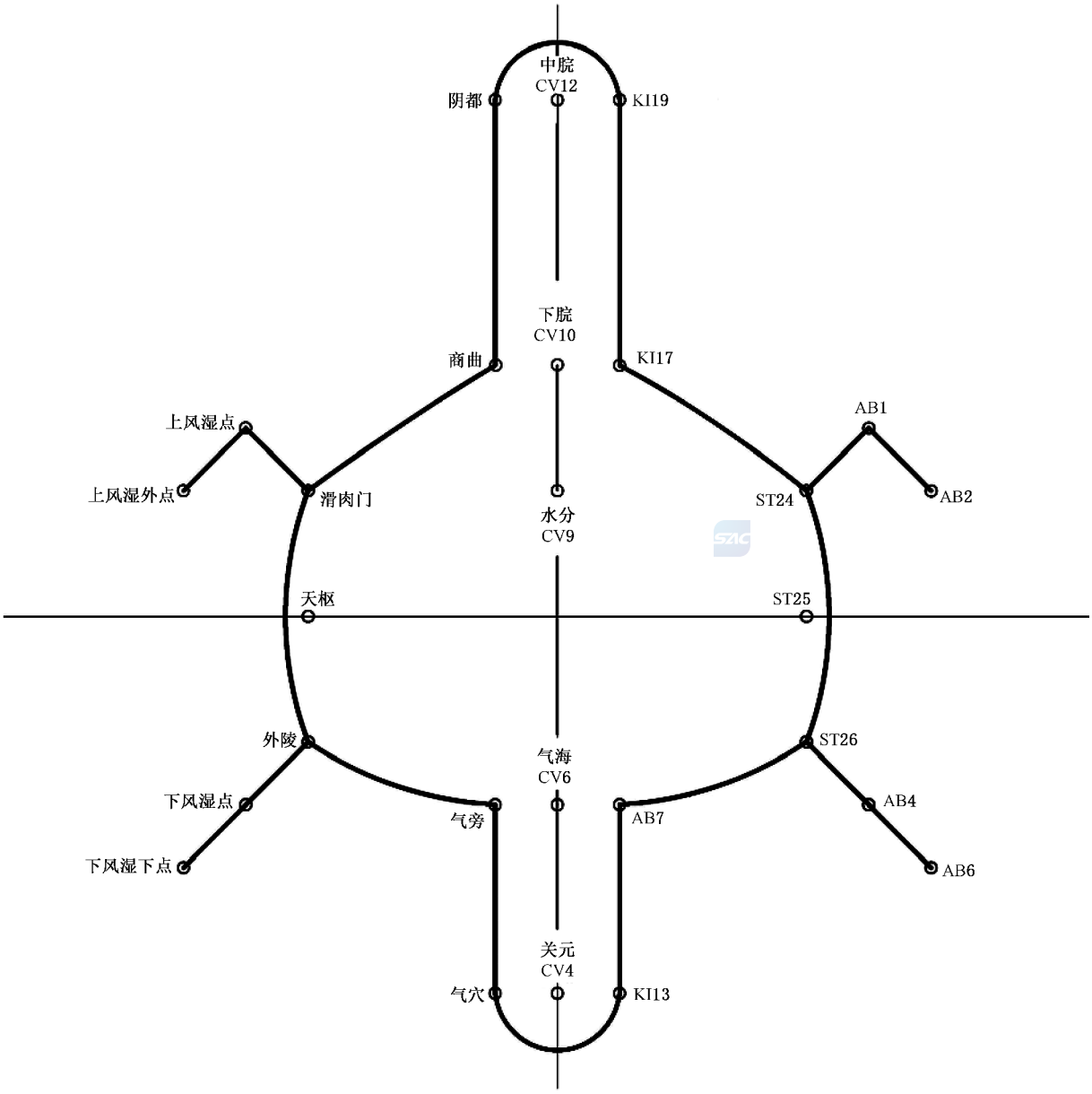

图 A.1　腹针取穴示意图

附　录　B
（资料性附录）
常用腹针刺法

在治疗疼痛性疾病时，常使用以下刺法，其中主穴是指病灶在腹部的对应穴点。

B.1　三角刺

以主穴为顶点，或上下，或左右各距 0.3 寸～0.5 寸，加刺两针，使三针形成等腰或等边三角形的多针刺法。此法适宜于肩关节疼痛、膝关节疼痛等疾病。

B.2　三星刺

以主穴为中点，向两侧各距 0.3 寸～0.5 寸，加刺两针，使三针形成直线排列的多针刺法。此法适宜于坐骨神经痛等疾病。

B.3　梅花刺

以主穴为中点，上下左右各距 0.3 寸～0.5 寸加刺一针，共 5 针，形成梅花图案的多针刺法。此法适宜于腰痛等疾病。

附　录　C
（资料性附录）
腹针处方原则

腹针处方是按照中医“君臣佐使”配方原则并结合针刺深度进行组方，具有一病一方的特点。

君穴、臣穴是根据病变脏腑主要病机所选的腧穴或穴点，应针刺到地部；佐穴是根据病变的次要病机所选的腧穴或穴点，应针刺到人部；使穴是根据病变部位所选的腧穴或穴点，应针刺到天部。

腹针进针时，一般按“先上后下、先内后外”的顺序。

附　录　D
（资料性附录）
腹针适应病症

D.1　内科

偏头痛、面神经麻痹、面肌痉挛、急性上呼吸道感染、哮喘、高血压、糖尿病、单纯性肥胖症、失眠症、焦虑症、抑郁症、中风后遗症、痛风、癫痫。

D.2　骨伤科

颈椎病(椎动脉型、神经根型)、肩周炎、肱骨外上髁炎、腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎、强直性脊柱炎。

D.3　妇科

月经不调、慢性盆腔炎、产后尿潴留、乳腺增生。